

MACOMPANHAMENTO () CONSULTA			
NS 22231570969 404			
CRISTIANO ROSSI GONÇALVES (mãe e pai fumante)			
IDADE:	PESO:	ALTURA:	PROFISSÃO:
SINTOMAS: mmII c/ leve edema/			
QUEIXAS: Sonolência (durante a direção) (não sente refluxo durante o sono)			
MEDICAMENTOS:			
HAS / Colesterol		SpO ₂ 80%	
MÉDICO:		cl SpO ₂ 81% cl CPAP	
MARCAPASSO: () S/DN / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S/DN			
EXERCÍCIO FÍSICO: 4x semana / 2x pilates/			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: lanche			
HORA QUE DORME: 23		HORA QUE ACORDA: 4hs (6-6:30)	
COCHILHO (X) SIM () NÃO 30'		DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO (X) EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () X NA SEMANA () NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: misto BANHEIRO:			
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: nega	MALLAMPATI: III	IAH: 11.5	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Rinite / sinusite			
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA Hernia de disco lombar			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não IMC:			
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA			
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS			
29/08 P= automática			
24 Umidif.			
06/09 P= 10,6 cmH ₂ O			
24 IAH= 0,7			
m. de uso: 7h11			
fuga= 6,8 lpm			
10/09 - Aliviado P fixa 9,2 cmH ₂ O			
20/09 P= 9,2 cmH ₂ O			
IAH= 0,4 e/h			
m. de uso: 7h44 min.			
fuga= 8 l/min			
23/09 P= 9,2 cmH ₂ O			
24 IAH= 0,4 e/h			
m. de uso: 7hs			
06/11/24 P= 9,2 cmH ₂ O			
IAH= 0,8 e/h			
m. de uso: 7h37			
fuga: 0,1 l/min			
27/11 P= 9,2 cmH ₂ O			
24 IAH= 0,8 e/h			
m. de uso: 7hs			
fuga= 0,0 lpm			

22/04 25 P = 92 cmHg
m de urd: 7h18l
Fuga = 0.4 lpu

ma



Clínica
DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
DOQJ ANTENA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
CRM-SP 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES
CRM-SP 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Cristiano Rossi Gonçalves
EXAME nº: 1314-3 CPAP
SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
DATA: 29/08/2016
IDADE: 42 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h08min e concluído às 06h06min. A latência para o sono foi de 2 minutos e a latência para o estágio REM, de 54 minutos. O tempo total de sono foi de 394,5 minutos (06h34min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 94,3%. A distribuição do sono mostrou 11,8% de estágio 1, 51,2% de estágio 2, 5,7% de estágio 3 e 31,3% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 22 minutos em vigília, ocorreram 62 microdespertares (Índice: 9,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apnéia/hipopnéia foi de 2,7/hora, sendo 1,1 apnéia/hora e 1,7 hipopnéia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apnéia+hipopnéia+RERA) foi de 4,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, a média de 93% e a mínima de 85%.

(*) TTS = Tempo Total de Sono

TTR = Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP (Resmed®), modo manual, sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia de Matos (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large® (Resmed®). A pressão final recomendada foi de 7,5 cm H₂O.

Os índices de apnéia/hipopnéia (2,7/hora; normal até 4/hora) e de distúrbio respiratório (4,7/hora) ficaram nos limites da normalidade. Registraram-se alguns episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina. O ritmo cardíaco foi sinusal e as frequências cardíacas foram: mínima: 49; máxima: 64 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 2 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (54 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (94,3%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (9,4/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (11,8%; normal: 8-10%) e REM (31,3%; normal: 20%), e a redução do estágio 3 (5,7%; normal: 10-12%). A porcentagem do estágio 2 (51,2%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Ausência de movimentos periódicos de membros.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



CRPSP
DR. ALBERTO REMESAR
Tratamento dos Distúrbios do Sono
Rua: Natália

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
CRM-SP 69.730
Endereço: Rua: Natália, 474 - Sala 51 e 52
Centro - São José dos Campos - SP
CEP: 12210-130 - fones: (12) 3941-2449 | 3913-2162

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES
CRM-SP 83.858
Endereço: Rua: Natália, 474 - Sala 51 e 52
Centro - São José dos Campos - SP
CEP: 12210-130 - fones: (12) 3941-2449 | 3913-2162

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Cristiano Rossi Gonçalves
EXAME nº: 1314-2
SOLICITADO POR: Dr. Flavio Augusto Passarelli Prado
DATA: 25/04/2016
IDADE: 41 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h36min e concluído às 06h15min. A latência para o sono foi de 1 minuto e a latência para o estágio REM, de 61 minutos. O tempo total de sono foi de 375 minutos (06h15min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 93,9%. A distribuição do sono mostrou 12,3% de estágio 1, 49,4% de estágio 2, 11,9% de estágio 3 e 26,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 23,5 minutos em vigília, ocorreram 125 microdespertares (Índice: 20/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 11,5/hora, sendo 2,7 apneia/hora e 8,8 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 22,4/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 94%, a média de 90% e a mínima de 80%.

(*) TTS ⇨ Tempo Total de Sono TTR ⇨ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos leve do índice de apneia/hipopneia (11,5/hora; normal até 4/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e moderado do índice de distúrbio respiratório (22,4/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, principalmente durante o sono REM, e despertares. O ritmo cardíaco foi sinusal e as frequências cardíacas foram: mínima: 57; máxima: 75 bpm.

O ronco foi intermitente e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 1 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava encurtada (61 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (93,9%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (125; 20/hora; normal: até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (12,3%; normal: 8-10%) e REM (26,5%; normal: 20%). As porcentagens dos estágios 2 (49,4%; normal: 45-55%) e 3 (11,9%; normal: 10-12%) permaneceram nos limites da normalidade.

Ausência de movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 21 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM - 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

CENTRO DE TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO

NOME: Cristiano Rossi Gonçalves

EXAME nº: 1314

SOLICITADO POR: Dra. Claudina Freitas de Moraes

DATA: 03/06/2009

IDADE: 34 anos

Alfredo Jorge Remesar Lopez CRM: 69730
Especialista em Medicina do Sono - Sociedade Brasileira de Sono
Mestre em Psiquiatria pela UFRJ
Doutor em Ciências pela UNIFESP

Comentários:

Exame iniciado à 00h25min e concluído às 06h04min. A latência para o sono foi de 2 minutos e a latência para o sono REM, de 62,5 minutos. O tempo total de sono foi de 316 minutos, com eficiência de sono (TTS / TTR) * de 93%. A distribuição do sono mostrou 9,2% de estágio 1, 70,4% de estágio 2, 1,7% de estágio 3 e 4 e 18,7% de sono REM. No período total de sono permaneceu 23 minutos em vigília, ocorreram 122 microdespertares (índice: 23,2/hora).

O índice de movimentos periódicos dos membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 3,6/hora, sendo 0,2 apneia/hora e 3,4 hipopneia/hora. O número total de eventos respiratórios foi de 19 sendo 0 misto, 19 obstrutivos e 0 central. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 98%, sendo a saturação média de 95% e a mínima de 88%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O índice de apneia/hipopneia (3,6/hora; normal até 4/hora) foi normal. Registraram-se alguns episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina após estes eventos respiratórios e aos de redução de fluxo aéreo, que terminavam em despertares. O ritmo cardíaco foi normal.

O ronco foi esporádico e baixo.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 2 min; normal até 20 min). A latência para o sono REM estava encurtada (62,5 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (93%; normal: 90% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (122; 23,2/hora; normal até 9/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1, ou estágio superficial do sono (9,2%; normal: 5%), e 2 (70,4%; normal: 45-55%) e a redução das porcentagens dos estágios 3-4 (1,7%; normal: 15-16%) e do sono REM (18,7%; normal: 20%).

Ausência de movimentos periódicos de membros e de contrações masseterinas.

Escala de sonolência de Epworth: 17 (sonolência diurna; normal até 10; máx: 24).

Conclusão final: exame compatível com o ronco e sugestivo de aumento da resistência em vias aéreas superiores.

Dr. Alfredo Jorge Remesar Lopez
CRM - 69730